

TEMA 1.3 • PEDIATRÍA

Tipos de Recién Nacido

PERFIL EUNACOM 2.01.1.128

Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

Tipos de Recién Nacido

1. Recién Nacido Pretérmino (Prematuro)

Definición: EG < 37 semanas (hasta 36 semanas + 6 días).

ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN

La **prematuridad** es la **primera causa de mortalidad infantil** en Chile.

Complicaciones principales (especialmente < 34 semanas):

TABLA 1.3.1: COMPLICACIÓN VS NOTAS

COMPLICACIÓN	NOTAS
Enfermedad de membrana hialina	Por déficit de surfactante
Enterocolitis necrotizante (ECN)	Necrosis intestinal, alta mortalidad
Hemorragia periventricular/intracerebral	Riesgo de secuela neurológica
Hipoglicemia	Muy frecuente, requiere control precoz
Hipocalcemia	
Hipotermia	Falta de grasa parda
Sepsis	Inmunodeficiencia relativa
Ictericia neonatal	Más severa y prolongada
Anemia	

PERLA CLÍNICA EUNACOM

Las 4 complicaciones graves (EMH, ECN, hemorragia periventricular, muerte) se pueden **prevenir** con **corticoides antenatales** en el manejo del parto prematuro.

- **Lo que el prematuro NO tiene:**
- **No hace poliglobulia** (solo anemia)
- **No tiene malformaciones** por su prematuridad (las malformaciones dependen de noxas durante el desarrollo embrionario, no de cuándo nace)

2. Recién Nacido Postérmino

Definición: EG > 42 semanas.

Causa principal de riesgo: **Insuficiencia placentaria** (la placenta envejece).

- **Complicaciones:**
- Hipoglicemia (disminuye el aporte nutricional)
- **Poliglobulia** (por hipoxia intrauterina crónica)
- **Asfisia perinatal**
- **Síndrome de aspiración meconial** (más meconio acumulado + riesgo de asfisia)
- **Conducta:**
- Interrumpir el embarazo a las **41 semanas** si no hay inicio espontáneo del trabajo de parto
- Si ya tiene 42 semanas: inducción con misoprostol (si condiciones para parto vaginal) o cesárea

3. Recién Nacido Pequeño para la Edad Gestacional (PEG)

Definición: Peso < **percentil 10** para la EG. Equivale al RCIU.

Causa: Insuficiencia placentaria (mismos riesgos que el postérmino).

- **Complicaciones:**

- **Hipoglicemia** (más frecuente e importante)
- **Poliglobulia**
- Asfisia perinatal
- **Hipotermia** (sin grasa parda, muy delgado)

Conducta: Manejo según Doppler fetal (igual que RCIU). Interrumpir según velocimetría Doppler de arteria cerebral media/umbilical.

4. Recién Nacido Grande para la Edad Gestacional (GEG)

Definición: Peso > **percentil 90** para la EG.

Causa principal: **Diabetes mellitus gestacional** (la mayoría). Algunos son constitucionales.

- **Complicaciones:**
- **Hipoglicemia** (la más importante y frecuente)
- Poliglobulia
- Complicaciones del parto: **distocia de hombros** (retención de hombros)

Conducta en GEG sin diabetes materna: Hemoglucotest a las **2 horas** de vida (momento de mayor riesgo de hipoglicemia).

ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN

En diabetes materna, el corte de **macrosomía** baja a **4.200 g** (no 4.500 g como en no diabéticas), porque el riesgo de distocia de hombros es mayor → indicación de cesárea.

5. Hijo de Madre Diabética (HMD)

Definición: RN cuya madre tuvo DM gestacional o pregestacional.

Complicaciones metabólicas (ambos tipos de DM):

TABLA 1.3.2: COMPLICACIÓN VS PRIORIDAD

COMPLICACIÓN	PRIORIDAD
Hipoglicemia	La más importante y frecuente
Poliglobulia	Por hiperinsulinismo fetal → eritropoyesis
Hipocalcemia	
Macrosomía (GEG)	Corte a 4.200 g
Polihidramnios	

En DM pregestacional (adicional):

- **Malformaciones congénitas** (la DM pregestacional afecta organogénesis): - **Defectos del tubo neural** (espinas bífidas, anencefalia) — las más importantes - **Cardiopatías congénitas** - Malformaciones de extremidades inferiores (amelia, hemimelia) - RCIU (insuficiencia placentaria) - Preeclampsia

PERLA CLÍNICA EUNACOM

Regla: Las malformaciones solo ocurren en la DM **pregestacional** (porque afecta el primer trimestre cuando se forman los órganos). La DM gestacional aparece después de la organogénesis.

Conducta en todo HMD: Hemoglucotest a las **2 horas** de vida.

Resumen Comparativo

TABLA 1.3.3: TIPO RN VS HIPOGLICEMIA				
TIPO RN	HIPOGLICEMIA	POLIGLOBULIA	MALFORMACIONES	CAUSA BASE
Pretérmino	Sí	No (anemia)	No	Prematuridad
Postérmino	Sí	Sí	No	Insuf. placentaria
PEG	Sí	Sí	No	Insuf. placentaria
GEG	Sí	Sí	No (salvo DM pregest.)	DM materna
HMD (gestacional)	Sí	Sí	No	DM materna

| HMD (pregestacional) | Sí | Sí | **Sí** | DM materna |

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:

"Un RN de 35 semanas presenta dificultad respiratoria desde el nacimiento con quejido, aleteo nasal y retracción subcostal. Rx tórax muestra opacidad en vidrio esmerilado bilateral. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?"

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para Tipos de Recién Nacido. Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- RN pretérmino <37 sem, término 37-41+6, postérmino ≥42 semanas de gestación
- PEG P90 del peso para la edad gestacional
- Membrana hialina (HMD): déficit de surfactante en pretérminos, distrés desde nacimiento
- Ictericia fisiológica: aparece >24h, pico día 3-5, siempre bilirrubina indirecta
- Ictericia patológica: aparece <24h, causa incompatibilidad ABO/Rh, requiere fototerapia urgente
- Hipoxia al nacer: APGAR <7 a los 5 min indica asfisia; reanimar con O2 + ventilación

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (TIPOS DE RECIÉN NACIDO)

PREGUNTA 1

Un RN de 35 semanas presenta dificultad respiratoria desde el nacimiento con quejido, aleteo nasal y retracción subcostal. Rx tórax muestra opacidad en vidrio esmerilado bilateral. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- A) Neumonía neonatal por Streptococcus grupo B
- B) Síndrome de aspiración meconial
- C) Enfermedad de membrana hialina por déficit de surfactante
- D) Taquipnea transitoria del recién nacido
- E) Neumotórax espontáneo neonatal

PREGUNTA 2

Recién nacido de 38 semanas, peso 2.100 g (P5 para la EG). ¿Cómo se clasifica este RN?

- A) Pretérmino AEG
- B) Término PEG
- C) Término AEG
- D) Postérmino PEG
- E) Pretérmino PEG

PREGUNTA 3

Un RN de 2 días de vida presenta ictericia. La bilirrubina total es 14 mg/dL (indirecta 13). Nació a término, peso adecuado, y la madre es A+ y el RN O+. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- A) Exanguinotransfusión inmediata
- B) Fototerapia según nomograma de Bhutani para RN término
- C) Alta con control ambulatorio en 48 horas
- D) Observación sin tratamiento, es ictericia fisiológica normal
- E) Suspender lactancia materna 48 horas

RESUMEN: TIPOS DE RECIÉN NACIDO

:::tip Las 4 complicaciones graves (EMH, ECN, hemorragia periventricular, muerte) se pueden prevenir con corticoides antenatales en el manejo del parto prematuro. ::: Conducta: Manejo según Doppler fetal (igual que RCIU). Interrumpir según velocimetría Doppler de arteria cerebral media/umbilical. Conducta en GEG sin diabetes materna: Hemoglucotest a las 2 horas de vida (momento de mayor riesgo de hipoglicemia).